ChatGPT

Az Érzelem–Stressz–Viselkedés (ESV) modell és a DSM-5 összehasonlító elemzése

Vezetői összefoglaló

Az ESV-modell egy viszonylag új, integrált pszichobiológiai keretrendszer, mely a mentális állapotokat négy dinamikus változó – a belső feszültség (Arousal), a szabályozó mechanizmusok (Protection), a külső terhelés (Hardship) és a testi állapot (Condition) – kölcsönhatásaként írja le [1] [2]. Ezzel szemben a DSM-5 rendszere egy klasszikus diagnosztikus kézikönyv, amely mentális zavarokat statikus tünetkategóriákba szervez, részletes tünetkritériumokkal és diagnosztikus kódokkal meghatározva az egyes betegségeket [3] [4]. Az ESV célja nem a klinikai diagnózis felállítása, hanem a funkcionális állapotfeltérképezés és beavatkozástámogatás a segítő szakmában [2] [5]. Míg a DSM-5 a pszichiátriai diagnózis nemzetközileg elfogadott standardja (betegségkategóriákat definiál a tudomány és klinikum számára) [3] [4], addig az ESV egy ún. „közös nyelvet" kínál a viselkedés mögötti dinamikus folyamatok megértéséhez [6] [5].

Az alábbi áttekintés részletesen tárgyalja a modellek eredetét és fejlődését, elméleti alapjait, fogalmi különbségeit, diagnosztikus struktúráját és operacionalizálását. Feltárjuk az empirikus kutatásokat (ESV-pilotvizsgálatok kis mintán [7] és DSM-5 megbízhatósági vizsgálatok [4]), valamint a klinikai és kutatási alkalmazások jellegét. Az összehasonlítás rámutat, hogy az ESV erőssége a rendszerszemlélet és prevencióorientált eszköztára (pl. 122 funkcionális állapotkód [6]), míg a DSM erőssége a széleskörű elfogadottság és a diagnosztikus kategorizálás elterjedt használata. A modellek gyengeségei közé tartozik az ESV esetében a kevés empirikus validáció és hivatalos támogatás hiánya [7] [5], míg a DSM-en belül kritika éri a klasszifikáció formalizmusát, a túldiagnosztizálás kockázatát és a kultúrafüggő torzításokat [8] [4]. A dokumentum összeveti továbbá a kultúrközi szempontokat (DSM-ben szerepel a Kulturális Formulációs Interjú, az ESV még lokálisan fejlesztett keret), valamint a gyakorlati és politikaorientált következményeket. Végül a jövőbeli kutatási irányokat és nyitott kérdéseket soroljuk fel, beleértve az ESV modell nagyobb mintás validációját és a DSM-diagnózisdimenziók további kutatását.

1. Történeti háttér és fejlődés

ESV-modell: Antal Ódor független kutató nevéhez fűződik az Érzelem–Stressz–Viselkedés (ESV) modell kidolgozása, amelynek első publikációi és kézikönyvei 2024–2025 körül jelentek meg (pl. *Az ESV-modell a függőségek mechanizmusában*, 2024; integrált szakmai kézikönyv, 2025) [9] [6]. A modell fejlesztése során a szerző rendszerelméleti és pszichobiológiai kutatásokat ötvözött (pl. polivagális elmélet, talamikus gátlás) [10]. A cél a mentális működés dinamikus folyamataival kapcsolatos új szemlélet megjelenítése volt, mint ahogy a szerző rámutatott: a hagyományos, top-down diagnosztikus paradigma korlátokra akadt súlyos stresszhelyzetek vagy traumák esetén [11] [12]. Az ESV-modell előfutára lehetett néhány korábbi, hasonló triadikus koncepció (pl. érzelem–stressz–viselkedés triád), de konkrét irodalmi előzménye nem volt széles körben publikálva, az Ódor által említett források mind saját, független kutatásai.

DSM-rendszer: A Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) története a második világháború utáni időszakig nyúlik vissza, de modern kiadásai az APA (Amerikai Pszichiátriai Társaság) kezdeményezésére készülnek. A DSM első kiadása 1952-ben jelent meg, majd később több revízión

esett át (DSM-II 1968, DSM-III 1980, DSM-III-R 1987, DSM-IV 1994, DSM-IV-TR 2000). A DSM-III vezetett be radikális újításokat: explicit diagnosztikus kritériumokat és többtengelyes rendszert, nagyfokú semlegességre törekedett az okok megjelölése nélkül [13] [14]. A DSM-5 kiadását 2013-ban tették közzé, hosszas kutatási előkészítés után (2000-től folyamatos fejlesztés, 2007-ben munkacsoportok, majd 2013-ban a végleges kézikönyv) [15]. A DSM-5-TR (Text Revision) 2022-ben került kiadásra, főként szöveges frissítésekkel és néhány új diagnózissal [16]. A DSM fejlődése során törekedtek az ICD (WHO betegségosztályozás) összhangjának növelésére (pl. DSM-IV és ICD-10 koordináció) [17].

2. Elméleti alapok és kulcsfogalmak

ESV-modell elmélete: Az ESV-modell a mentális állapotokat nem betegségkategóriákban, hanem az idegrendszer és a környezet közötti dinamikus kölcsönhatásokban keresi. A modell négy változója – Arousal (belső feszültség vagy energetikai töltés), Protection (a szabályozó, küzdő- vagy elkerülő mechanizmusok), Hardship (külső stressz vagy terhelés) és Condition (testi/szomatikus állapot) – mérésekkel jellemezhető [1] [18]. Az Arousal mutatja az "energetikai nyomást" a rendszerben, a Protection az ehhez kapcsolódó védelmi vagy megküzdési választ jelzi (akár adaptív, akár maladaptív formában) [1] [19]. A Hardship a külső kontextust (például élethelyzetbeli stresszorokat) modellezi, a Condition pedig a szervezet aktuális kapacitását és alaphelyzetét írja le (pl. fizikai egészség, előző traumák állapota) [18] [20]. Az elmélet szerint mentális szenvedés esetén ezek a változók diszharmonikus egyensúlyt vesznek fel, és önfenntartó „pszichés kényszerhurkok" alakulhatnak ki [21]. Ez a ciklikus, visszacsatolási szemlélet kulcsa: nem egy külső esemény vagy hibás agyi funkció okozza a gondot, hanem egy önállóan szabályozó, körkörös folyamat, amelyben az érzelmi válasz, a stresszreakció és a viselkedés egymást erősíti még az eredeti ok elmúltával is [12] [22].

DSM elmélete és koncepciói: A DSM szemlélete elsődlegesen leíró és kategorizáló: a mentális zavarokat meghatározott tünetegyüttesek jelenlétéhez köti, a lehetséges diagnosztikus határok pedig főként szakkonszenzuson és klinikai kutatásokon alapulnak. A DSM-5 definíciói szerint a mentális zavar olyan pszichológiai vagy viselkedéses tünetegyüttes, amely szenvedést vagy működési zavarokat okoz az egyén életében. A kézikönyv nem kapcsolódik közvetlen elméleti modellhez vagy neurobiológiai magyarázathoz, inkább „követelője" az egyszerű, operationalizált diagnózisoknak: minden zavarhoz listáz egy-egy kritériumcsaládot, amelyek teljesülése esetén a személy az adott betegséggel diagnosztizálható. A DSM-5 szakított a DSM-III/DSM-IV kéttengelyes rendszerével, és számos diagnózist spektrumként interpretál (pl. az autizmus spektrumzavar egyesítése) [23]. Fontos jellemzője, hogy a diagnózis neutral az etiológia tekintetében: a kritériumok elsősorban viselkedéses és szubjektív tüneteket írnak le, nem a kiváltó okokat. A DSM-5 bevezetett kiegészítő eszközöket is (pl. transzkulturális diagnosztikai modul, cross-cutting symptom skálák, funkcionális térképezők), de a fő struktúra továbbra is a kategóriák és tünetlisták hálózata [24].

3. Célok, alkalmazási területek és céljelenségek

ESV célja és területei: Az ESV-modell alapvető célkitűzése a mentális állapotok funkcionális feltérképezése és a segítő szakmában (pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, szociális munkások, pedagógusok stb.) való döntéstámogatás [25] [5]. A kézikönyv hangsúlyozza, hogy az ESV nem klinikai diagnosztikai rendszer, hanem a kliens aktuális teherbíró képességének, megküzdési stratégiáinak és állapotváltozásainak megértését szolgálja [26] [5]. Konkrét területek, ahol ESV-t alkalmaznak, például traumamegelőzés, kiégés korai felismerése, viselkedéselemzés speciális nevelési-oktatási környezetben [5] [27]. A modell napjainkban leginkább kutatási és pedagógiai környezetekben jelenik meg, illetve független tanulmányokban (például a gyógypedagógiai terepalkalmazás vagy a függőségek kezelésének elemzése) [27] [9]. Lényege, hogy a viselkedés mögött rejlő érzelemszabályozási folyamatokat és környezeti stresszforrásokat térképezze, nem pedig új

„betegségek” felállítását tűzze ki célként. Az ESV-modell nem helyettesíti a hagyományos pszichiátriai diagnózist és terápiát, csupán kiegészíti azt a funkcionális szemlélet révén [2] [5].

DSM célja és területei: A DSM rendszere eredetileg a pszichiátria és klinikai pszichológia számára készült standardos diagnosztikai kézikönyvként. Az APA szándéka szerint a DSM segíti a pszichiátereket és kutatókat a mentális zavarok egységes terminológiájának fenntartásában, kutatásában és a biztosítói/költségelszámolási rendszerben való felhasználásban [13] [4]. A DSM minden kiadása arra törekszik, hogy kódszámokat és kritériumokat adjon például a diagnózisok epidemiológiai statisztikáinak gyűjtéséhez, a biztosítási elszámolásokhoz és a klinikai kutatások standardizálásához is. A DSM-5 céljai között szerepelt a szöveges ismertetők frissítése a legújabb kutatások alapján, valamint egyes új kategóriák (pl. hosszan tartó gyász zavar) bevezetése [16]. Feladata továbbá, hogy segítse a klinikusokat a helyes diagnózis felállításában (azaz leírja, hogy mely tünetekkel, milyen minta áll fenn egy adott zavar esetén), de nem terjed ki magyarázatok vagy közvetlen terápiás ajánlások adására. Összességében a DSM célja a diagnosztikus kategóriák egységes használata és a mentális zavarok objektív azonosíthatóságának előmozdítása a kutatás és gyakorlat számára [3] [28].

4. Diagnosztikus struktúra és kritériumok

DSM-5 struktúrája: A DSM-5 a mentális zavarokat nagy fejezetekbe csoportosítja (pl. neurózisok, hangulatzavarok, szkizofréniaspektrum, neurofejlődési zavarok, személyiségzavarok stb.). Minden zavarhoz meghatároz egy vagy több diagnosztikus kritériumcsoportot, amelyek közös tünetek (pl. depresszió esetén levert hangulat, érdeklődés elvesztése, alvászavar, súlyváltozás stb.) felsorolásán alapulnak. Egy diagnózis létrejöttéhez a kritériumok között számszerű követelmények vannak (például az adott tünetek közül legalább kettő-három fennállása, bizonyos időtartamon át) és kizárási feltételek (pl. más betegség kizárása, kóros anyaghatás kizárása). A DSM-5 nem használ többtengelyes rendszert (tengelyek eltörlése a DSM-IV-hez képest), viszont bevezette a „cross-cutting” transzdiasztikus tünetkérdőíveket és a társuló tényezők mérését is a diagnózis kitűzött dátumánál. A diagnosztikus kézikönyvben a betegek pszichopatológiai jellemzőit pontozható módon (például súlyossági skálákkal) is rögzítik bizonyos esetekben, de összességében szigorú kategorizáláson alapul. A DSM struktúrája rendezi az egyes diagnózisokat, minden kategórián belül pontos definíciókkal és szakirodalmi háttérrel, valamint javaslatokkal a differenciáldiagnózisra és szövődményekre.

ESV diagnosztikus keretrendszer: Az ESV nem betegségkategóriákat, hanem ún. funkcionális állapotkódokat használ. A kliens aktuális állapotát négy számjegyű ESV-kód fejezi ki (A–P–H–C forma, ahol A= Arousal, P= Protection, H= Hardship, C= Condition, mindegyik 1-től 4-ig terjedő skálán) [29] [30]. Például a “1141” kód azt jelenti, hogy alacsony éberség (A=1), rendkívül magas szomatikus panaszok (C=4) mellett a kliens nem jelez stresszt (H=1) és kezdetleges védekezési kapacitás jellemzi (P=1) [31]. A kézikönyvben összesen 122 egyedi funkcionális állapotprofilt különböztetnek meg, és minden kódhoz részletes leírás és beavatkozási protokoll tartozik [32]. Az ESV-kódok nem orvosi diagnóziscímkék, hanem a kliens mentális működésének pillanatnyi dinamikus mintázatát írják le [33] [2]. Így például egy magas Arousal–gyenge Protection–magas Hardship–alacsony Condition kombináció egy akut stresszreakciót vagy kis későbbi kimerülést mutathat (például az “1131” kód rejtett stresszprofil). Az értelmezés során a szakember nem pszichés betegségcímkét ír fel, hanem a kapott ESV-kód alapján a kliens belső működésének mintázatát térképezi fel [33] [21]. Fontos hangsúly, hogy az ESV-kód a dinamikus folyamatokat ragadja meg, nem pedig kórisme megállapítását (tehát az állapotok csak szimptomatikus leírások a kliens aktuális pszichés állapotáról) [2] [5]. Az ESV nem tartalmaz merev kategóriákat vagy többtengelyes struktúrát, hanem egy négydimenziós skálát alkalmaz, amelyben a négy faktor együttesen határozza meg a funkcionális állapotot.

5. Módszertan és operacionalizáció

ESV mérőeszköz és módszertan: Az ESV-modell gyakorlati alkalmazásához kidolgozták az „ESV-25 Inventory” nevű kérdőívet és funkcionális elemző protokollokat [34] [35]. Az ESV-25 egy rövidített mérőlap, amely a négy változót érzékelteti a kliens szubjektív bevallása alapján. A modell hatékonyságát azáltal értékelik, hogy a kitöltés során a válaszadó a négy dimenzió mentén kap egy pillanatnyi állapotértéket, amelyből az ESV-kód kiszámítható. A kézikönyv szerint a kérdőív statisztikailag validált (például faktoranalízissel ellenőrizve) [36] [37], habár a teljes validációs folyamatot publikált közleményekben még nem részletezték. Emellett az ESV tartalmazza a funkcionális állapotleíró kézikönyvet és beavatkozási protokollokat: ezekben a kódszámokhoz kötve javasolnak terápiás vagy pedagógiai lépéseket (pl. érzelemszabályozás-fejlesztés, stressz inventory készítése) [38] [39]. Az ESV-terepalkalmazás során kvalitatív megfigyelések és interjúk is használatosak, de a modell maga főként a kérdőíves skála eredményeire épít. A bevezető fejezetek jelzik, hogy a változók méréséhez több, jól bevált pszichológiai skálát (STAI a szorongásra, DERS az érzelemszabályozásra, PSS a stresszre, PHQ-15 a testi tünetekre) használtak mint archetípusokat a validálás során [40]. Ezen felül a modell szemléletét alkalmazzák például csoportdinamikai keretrendszerként is (ESV-rendszer csoportokra). Mindez utal rá, hogy a módszertani alapok pszichometriai eljárásokon (skálák, korrelációk, faktoranalízis) és rendszerelméleti elemzésen alapulnak.

DSM módszertan és operacionalizáció: A DSM nem kínál konkrét mérőeszközt, hanem azokat a diagnosztikus eljárásokat használja, amelyek jól beváltak klinikai gyakorlatban. A DSM diagnózisok felállításához gyakran strukturált vagy félstrukturált interjúkat (pl. SCID, MINI, K-SADS) alkalmaznak, amelyek a kézikönyv kritériumait kérdésformába ültetik át. Emellett egyes zavarokhoz (pl. depresszió, szorongás) léteznek standardizált önbevalláson alapuló skálák (pl. Beck Depression Inventory, HAM-A), de ezek általában a DSM-definíciók mérésére szolgálnak, nem a DSM-5 részei. A DSM-5 bevezette a globális funkciót mérő GAF helyébe lépett WHODAS® 2.0 mérőeszközt is, valamint a keresztmetszetű tünetkérdőíveket, amelyekkel a diagnózis előtti szűrés egész személyiségre kiterjedő felmérést tesz lehetővé [8] [24]. A diagnózis validálásához gyakran használnak kontrollcsoportos vizsgálatokat és prospektív epidemiológiai felméréseket. A DSM-5 fejlesztői számos pszichiátriai interjút és korábbi kritériumrendszert (például DSM-IV, ICD-10) tanulmányoztak, mielőtt új diagnosztikus kritériumokat javasoltak. A DSM-rendszer megbízhatóságát és konzisztenciáját tesztelték ún. field trial-okkal is: pl. 2013-ban a DSM-5 mezőpróbák során kappa-számítással becsülték, hogy két független klinikus mennyire érthet egyet ugyanazon beteg diagnózisában [4]. A DSM-ben így az operacionalizáció jellemzője a széles körben szabványosított klinikai interjúk és pszichometriai mérőeszközök használata, míg a validálás nagyszabású klinikai és kutatási vizsgálatok eredményein alapul.

6. Empirikus bizonyítékok és validáció

ESV-modellempria: Az ESV-modell kutatása még kezdeti stádiumban van, így az empirikus bizonyítékok elsősorban pilot vizsgálatokra és terepi beszámolókra épülnek. Egy 2025-ös tanulmányban 13 fős mintán vizsgálták kérdőíves módszerrel az ESV hipotéziseit [7]. Az eredményekben szignifikáns korrelációkat találtak az állapotszorongás, a stressz és az érzelmi szabályozás faktorai között, míg a pszichoszomatikus tünetek kapcsolódása kevésbé bizonyult erősnek. A szerzők szerint ezek az eredmények alátámasztják az ESV modell logikáját (azaz, hogy az érzelmi állapotok és a stressz kölcsönhatásban vannak) [7]. Ugyanakkor a vizsgálat mintanagysága kicsi (N=13), így a statisztikai erő korlátozott és a következtetések feltételesek. Egy másik forrás a 2026-os „ESV funkcionális elemzési kézikönyv” előzetes leírása szerint több mint 50 fős empirikus alap áll rendelkezésre a 122 állapotprofil kiválasztásához [35], de részletek itt sem közöltek közleményben. A terepalkalmazásról szóló kvalitatív beszámolók (gyógypedagógiai környezetben) azt sugallják, hogy az ESV szemlélet érzékenyen reagál traumatikus hiányokra és viselkedési mintákra [27] [5]. Összességében az ESV-t támogató empíria

jelenleg részben publikálatlan anyagokon és kis előkísérleteken alapul, amelyek előzetes ígéretet mutatnak, de nagyobb populációs és kontrollcsoportos vizsgálatokkal még nem erősítették meg. A szerzők maguk is elismerik, hogy kvantitatív validálásra van szükség [5].

DSM-5 validációs vizsgálatok: A DSM évtizedek óta a pszichiátria standardja, így számos empirikus eredmény áll rendelkezésre diagnosztikus megbízhatóságra és gyakoriságra vonatkozóan. A DSM-5-tel kapcsolatban az egyik legfőbb bizonyíték a 2013-as mezőpróbák eredményei. Darrel Regier és mtsai publikáltak olyan teszt–retesz megbízhatósági vizsgálatot, amelyben klinikusok egymástól függetlenül diagnosztizáltak betegeket. Eredményeik szerint a vizsgált diagnózisok fele „jó" vagy „nagyon jó" megbízhatóságú (κ>0,4) volt [4]. Konkrétan öt diagnózis esett a nagyon jó (κ=0,60–0,79) kategóriába és kilenc a jó (κ=0,40–0,59) kategóriába, míg hat „kérdéses" (κ=0,20–0,39) és három „elfogadhatatlan" (κ<0,20) megbízhatóságú volt [4]. Ez azt jelzi, hogy a DSM-5 kritériumrendszerek többsége viszonylag stabil, de néhány diagnózisban (pl. szélesebb spektrumú zavarok vagy új kódolások) még vannak ambivalenciák. Emellett a DSM-5 kritériumainak validitását tanulmányozták epidemiológiai felmérésekkel (pl. prevalencia vizsgálatok szerint a lakosság jelentős hányadának van valamilyen DSM-szerinti zavarja) és agyi kutatásokkal (pl. képalkotó vizsgálatok bizonyos zavarok eltéréseket mutatnak). Fontos megjegyezni azonban, hogy a DSM-5 alapvetően konszenzusos folyamat eredménye, és nem minden kritérium szorul kutatásalapú cáfolatra vagy alátámasztásra.

Eredmények és korlátok: Az ESV esetén a rendelkezésre álló empirikus adatok korlátozottak és kezdetlegesek. A hatások (korrelációk a pilot vizsgálatban) összhangban vannak az elméleti várakozásokkal [7], de a kis minták miatt hatásnagyságokról, általánosíthatóságról nem lehet statisztikailag erős következtetéseket levonni. A DSM-5 vonatkozásában a rendelkezésre álló kutatások széles körűek, de nem minden kérdés eldöntött. Például a széles diagnózisspektrumok bevezetése (pl. autizmus spektrum) egyesek szerint túl sok normál eltérést patológiásnak minősít, mások szerint segít a súlyosság dimenziójának megjelenítésében [23]. Wakefield szerint a DSM-5-öt feszítő viták központjában az áll, hogy hol húzzuk meg a határt normális és kóros viselkedés között [8]. Így az evidenciák kapcsán vitás kérdés a DSM kiterjesztett diagnózisaival és az ESV gazdag, de eddig kis elemszámú támogatásával.

7. Klinikai és kutatási alkalmazások

ESV alkalmazások: Az ESV elsősorban prevenciós és szupportív környezetben használatos. Nem egészségügyi kereskedelmi eszköz, ezért gyakran alkalmazzák ingyenesen mentorok, tanácsadók, pedagógusok és önkéntes segítők is a mindennapi kliensek helyzetének felmérésére [41] [5]. Klinikai környezetben alkalmazva inkább kiegészítés (például pszichológiai tanácsadás, mentálhigiéné), nem pedig fő diagnosztikai eszköz [5] [35]. Gyógypedagógiai és oktatási terepalkalmazásai például co-regulációs és transzferenciális módszerek kialakítására irányulnak, ahol a pedagógus a viselkedés mögötti érzelmi-stressz faktorokat veszi figyelembe [27]. Egyes kutatók az ESV-t speciális populációk (traumatikus háttérrel élők, kiégésre hajlamos szakemberek, függőségben szenvedők) segítő eszközeként említik, mivel a modell képes a környezeti és belső tényezők integrált elemzésére [9] [27]. A modellhez kapcsolódó protokollok (pl. állapotfelmérő kézikönyv, stratégiaválasztás) lehetővé teszik, hogy a szakember konkrét beavatkozásokat válasszon az aktuális ESV-kód alapján. A 2025-ben készült módszertani beszámoló hangsúlyozza, hogy az ESV hatékonyan egészíti ki a pedagógiai munkát érzelmi edukáció és stresszreguláció terén [5]. Kutatásban eddig főként kvalitatív és kis próbák jelzik a működését.

DSM alkalmazások: A DSM-5 használata széles körű és jól dokumentált. Klinikai praxisban pszichiáterek, pszichológusok, háziorvosok használják a diagnózis felállítására és gondozás tervezésére. Az egészségügyi biztosítók és adminisztratív szervek is a DSM- (és ICD-) kódokra építenek számlázást és

statisztikagyűjtést. Kutatásban a DSM-5 kritériumok szerint beválogatott mintákban végzett vizsgálatok alapján ismerünk gyakorisági adatokat, kockázati tényezőket és prognózist. A DSM-5-öt alkalmazzák pszichofarmakológiai gyógyszerkutatásban, epidemiológiai felmérésekben (pl. nemzeti egészségügyi felmérések használják), illetve pszichoterápiás tanulmányokban, ahol a betegek DSM-diagnózisai szerint csoportosítanak. Hátránya, hogy alkalmazása felszínes képet adhat (tünetekre koncentrál), és nem biztosít szemantikai magyarázatot a probléma eredetére. Ennek ellenére a DSM-5 a nemzetközi szakmai gyakorlat sarokköve, és az összehasonlításban szokták arany standardként emlegetni.

8. Erősségek, gyengeségek és viták

ESV erősségei: Az ESV-modell egyik legfőbb erőssége a rendszerszintű és prevencióorientált szemlélete. Több változóra épít, így komplexen írja le a kliens állapotát (nem csak egy kategória megjelölését teszi lehetővé) [1] [21]. A rendszeres alkalmazás segíthet abban, hogy a segítő szakember a kliens aktuális teherbíró-képességét és kockázatait dinamikusan felmérje, és célzottabban avatkozzon be. Integrálja a neurobiológiai ismereteket (pl. polyvagális elmélet, limbikus válaszok) a klinikai gyakorlatba, ami innovatív megközelítés a magyar pszichológiai eszköztárban [10] [9]. A modell adaptív, mert elkerüli a merev diagnózisokat, ezért lényeges komponense lehet a prevenciós szakasznak (korai burnout- vagy trauma-érzékelés) [42] [5]. Az ESV „közös nyelv”-ként is működik, közvetíti az érzelmi-szomatikus folyamatok összefüggéseit az oktatók és tanácsadók között.

ESV gyengeségei és korlátai: A legjelentősebb gyengeség a még kevés empirikus bizonyíték és a validáció hiánya. A rendelkezésre álló tanulmányok kis mintákon, pilot jelleggel történtek [7]. Nincs széles körben elérhető standardizált adatbázis az ESV-kódokra, és a mérőeszközök (ESV-25) hatékonyságát sem tesztelték számos független kutatásban. Mivel a módszerek publikációi főként preprint vagy szakmai kézikönyv formájában érhetők el, a szakmai közösség számára még nem nyílt lehetőség az átlátható kritikai értékelésre. A modell komplexitása és a 122 kategória használata tanulást és szakértelmet igényel, nem automatikus eszköz. Kritikusok felvethetik, hogy az ESV gyakorlatilag új keret, így hiányozhat belőle a hivatalos elismertség (nincs WHO- vagy APA-tanúsítvány). Az is kérdéses, hogy a modell kulturális univerzális-e, hiszen magyar fejlesztésű, elsősorban magyar környezetben tesztelt. További bizonyítékok nélkül nehéz eldönteni, mennyire teljeskörű vagy más modellekkel (pl. ICD-11) összehasonlítva mennyire megbízható.

DSM erősségei: A DSM-5 fő erőssége a széles körű elterjedtség és szabványosság. A mentális egészségügyben világszerte elfogadott referenciakeretrendszer, amelynek fogalmai és kódjai beépültek a biztosítási elszámolásokba és a jogi keretekbe [3] [28]. A diagnózisok javára szolgál az ismert terminológia és kommunikációs nyelv, amelyet klinikusok és kutatók egyaránt használnak. A DSM-5 fejlesztése során nagyszámú szakértő (200+) és tudományos munka vett részt, így a kategóriák számos klinikai kutatáson alapulnak [15]. A field trial-ok alapján a legtöbb DSM-kategória megbízhatósága jó szintű [4], és a rendszer javította az előző kiadások többször előkerült pontatlanságait. A DSM-5 tartalmazza a kulturális tényezőket és a dimenziós értékelést is (különös tekintettel a tünetek súlyosságára), ami rugalmasabbá teszi.

DSM gyengeségei és viták: A DSM egyik leggyakoribb kritikai pontja a patológiásítás kockázata: attól tartanak, hogy a normalitás széles spektrumát diagnosztikus kategóriákkal írják le, ezzel false positive helyzeteket teremtve [8]. Például a DSM-5 javaslatokra adott erős reakciók hátterében részben az áll, hogy bizonyos új kórok beemelése vagy kritériummódosítás hogyan változtatja meg a diagnózisok gyakoriságát. A DSM-et „betegségkategóriákba sémásító” rendszerként is bírálják, mivel az emberi psziché ún. „piszkos valóságát” nem minden esetben ragadják meg élesen [11] [8]. Másrészt a DSM-kritikusok felhívják a figyelmet arra, hogy a rendszer túlságosan tünetalapú és kevés figyelmet fordít az egyéni történetre, a fejlődési és társadalmi tényezőkre (e probléma kezelésére vezették be például a

Kulturális Formulációs Interjút) [43]. A DSM-5 körüli viták rámutattak a diagnózisok érvényességének kérdésére: hol húzzuk meg a határt normális és rendellenes között, és milyen kontextusban jelenjenek meg a tünetek [8]. Végül a DSM-5 eltávolította az enyhébb spektrumú diagnózisok közül néhányat (pl. depresszióban a gyász kizárását), ami ellenhatásokhoz vezetett. Mindezek a kérdések tudományos vitákat generáltak, amelyek folyamatos kutatást igényelnek.

9. Keresztkulturális megfontolások

DSM kultúrafüggőségei: A DSM rendszerei eredetileg nyugati pszichiátriai kontextusból származnak, és a kritikusok szerint fontos kulturális torzításokat is tartalmazhatnak. A DSM-5 céljainak része volt a kulturális szempontok hangsúlyozása: bevezették a *Cultural Concepts of Distress* (kultúrafüggő megnyilvánulások) kategóriákat, és a DSM-5-TR széleskörű etnorasszista egyenlőségi felülvizsgálatot tartalmazott [16] [44]. A *Cultural Formulation Interview* (kulturális formulációs interjú) segíti a klinikusokat abban, hogy a páciens saját kulturális kereteit megismerjék. Ennek ellenére a DSM-5-öt nemzetközileg is használják, és számos országban hivatalos fordítás készült belőle. Az ICD-11 (WHO klasszifikáció) konkurens rendszere is változtatja a definíciókat, de törekszik összhangra a DSM-mel. A kulturális aspektusoknál mérlegelni kell, hogy egy mentális zavar diagnózisa mennyire univerzális fogalom; pl. az érzelmi tünetek megélése, a stigma, a társadalmi normák eltérőek lehetnek a különböző kultúrákban. A DSM-5 törekszik ezek figyelembevételére, de a modell alapja továbbra is klasszikus kategorizáció.

ESV kultúrális megfontolások: Az ESV-modell jelenleg főleg magyar nyelvű irodalomban, magyar fejlesztők által használatos. Nincsenek publikált adaptációk más kultúrákra vagy nyelvekre. Mivel a modell önmagában nem tartalmaz kulturális elemeket (például specifikus kultúrához igazított kérdőív vagy kulturális dimenzió), kérdéses a más kontextusokban való alkalmazhatósága. Előnye azonban, hogy elvileg univerzálisnak tekinti az érzelmek és stresszreguláció neurobiológiai alapelemeit, így más kultúrák is adaptálhatják. Hacsak nem végzik el a modell kulturális validálását, addig nem áll rendelkezésre tudományos adat, hogy például nem magyar népességre is érvényes-e. Összehasonlításképpen, a DSM szisztematikusan veszi számításba a kultúra szerepét (külön alfejezetek a kulturális faktorokról), míg az ESV esetében jelenleg ez hiányzik.

10. Következmények a gyakorlatban és jövőbeli kutatási irányok

Az ESV-modell bevezetése világszerte nem versenyez a DSM-mel, inkább kiegészítő eszközként jelenhet meg. Gyakorlati gyógyítási vagy oktatási kontextusban az ESV segítségével a szakemberek jobban fókuszálhatnak a kliens állapotának finom dinamikájára (pl. korai stresszjeleket, érzelemszabályozás hiányosságait kereshetik), ami hozzájárulhat a személyre szabott intervencióhoz [21] [5]. A modellt alkalmazó szakértők mintául tekinthetik a diagnosztikus megközelítés és a terápiás támogató folyamat közötti hidat (ahogy a szerző fogalmaz: „közös nyelvet” teremt a szubjektív élmények és a szakmai megfigyelés között [36] [34]). A DSM használata továbbra is előírás a pszichiátriai ellátásban és kutatásban (diagnózisok, betegstatisztika, gyógyszerfejlesztés), így annak gyakorlati következményei ismertek és mélyek. A jövőben várható, hogy a DSM-5-TR-hez kapcsolódó módosításokat és az ICD-11/ICD-11-CM rendszereket egyre szorosabban közelítik össze, és hogy a diagnosztikus kritériumok finomhangolása révén csökkentsék a megbízhatatlanságot.

További kutatási lépések (ajánlott):
- **ESV-validálás:** Nagyléptékű empirikus vizsgálatok indítása, amelyek összehasonlítják az ESV-25 felmérést standard pszichológiai mérőeszközökkel és klinikai diagnózisokkal. Ide tartozhat longitudinális kutatás is (például ESV-kódok előrejelző értékének vizsgálata egy éven belül).
- **Klinikai hatékonyság:** Kontrollcsoportos kísérletek indítása arra, hogy az ESV-alapú beavatkozások (pl. kódkritériumok alapján végzett támogatás) milyen mértékben javítják a kliens állapotát a

hagyományos módszerekhez képest.
- **Modelldiverzifikáció és dimenziók:** Az ESV további fejlesztése más pszichológiai változókkal (pl. Neuroticism, kötődés) való integráció irányába, valamint vizsgálatok, hogy az ESV kódok hogyan illeszkednek az ICD-11 keretrendszerbe.
- **Kulturális adaptáció:** Az ESV-modell fordítása és kipróbálása más nyelvterületeken, hogy kiderüljön, például más európai vagy távol-keleti kultúrákban is értelmezhető-e.
- **DSM-kutatások:** A DSM-5 eddigi vitás pontjainak további vizsgálata, pl. a gyászra vonatkozó kritériumok hatása, a spektrumzavarok dimenzionalitása, valamint az újonnan bevezetett diagnózisok klinikai relevanciája.
- **Követéses vizsgálatok:** Mindkét rendszer esetében hasznosak hosszú távú hatásvizsgálatok (például hogy a DSM-5 diagnózisok felállítása milyen eredményt hoz 5 év múlva, vagy hogy ESV-állapotmonitorozás esetén mennyivel csökken a kiégés előfordulása).

11. Összehasonlító táblázatok

Jellemző / Kritérium	ESV-modell (Odor, 2024–2025) [1] [2]	DSM-5 (APA, 2013) [3] [4]
Áttekintés	Rendszerszemléletű, dinamikus változók együttese (A, P, H, C) és visszacsatolásai [1] [21]. Nem betegségkategóriák, hanem funkcionális állapotkódok (4 számjegyű). Modellezési cél: kliens állapotának folyamat-orientált feltérképezése.	Betegségkategóriák statikus felsorolása tünetkritériumokkal. Klinikai diagnosztikus kézikönyv mentális zavarok leírására és osztályozására [3]. Egységes diagnózisok és kódok rendszere (számszimbólumok) a betegségfelismeréshez.
Elméleti alap	Pszichobiológiai integráció: érzelemszabályozás, stressz-adaptáció, idegi self-reguláció (polyvagális elmélet, thalamus szerepe) [10]. Funkcionális pszichológia, körkörös kauzalitás, feedback-loop koncepció [12] [22].	Deskriptív, orvosi modell: a zavarok tünetein alapuló kategorizálása. Nincs mély ok-elemzés az etiológiára; a DSM-5 törekszik a semleges, kutatáson alapuló definíciókra. Keresztmetszeti pszichopatológia, részben spektrális megközelítések (pl. autizmus, szorongás spektrum).
Diagnosztikai struktúra	Nincs „diagnózis” per se; 4 dimenziós ESV-kód generálása (pl. 1131, 1141 stb.) leírja a kliens pillanatnyi mentális dinamikáját [33] [38]. 122 lehetséges profil van, a kódok a belső állapotokat és megküzdést jellemzik. Nem használ DSM- vagy ICD-kategóriákat [2].	Betegségek listája fejezetekben. Minden kórkép kritériumcsoportját tünetek és időtartam alapján részletezi (pl. több fokú tünetlista). Diagnózishoz meghatározott számú tünet teljesülését írja elő, kizáró kritériumokat is tartalmaz. Többször módosult (pl. DSM-IV-II tengelyek eltörlése, spektrumzavarok bevezetése).

Jellemző / Kritérium	ESV-modell (Odor, 2024–2025) [1] [2]	DSM-5 (APA, 2013) [3] [4]
Módszertan / mérőeszköz	ESV-25 önkitöltős kérdőív (4 komponens) a funkcionális állapot kódolására [10] [37] . Funkcionális állapotleíró és beavatkozási kézikönyv segíti a kódok értelmezését és a szakmai teendőket. Terápiás és fejlesztőpedagógiai célokra ajánlott eszközöket (pl. érzelmi tudatosság fejlesztése, stressz-leltár) sorol fel a forrás [31] [5] . Validálás páros skálákkal: STAI (Arousal), DERS (Protection), PSS (Hardship), PHQ-15 (Condition) [40] .	Strukturált vagy félstrukturált pszichiátriai interjúk (SCID, MINI stb.), standard skálák (pl. HDRS, BDI) a tünetek mérésére. ICD-10-CM kódok összhangja. Speciális DSM-5* kiegészítők: pl. Culture Formulation Interview (kultúrafeltérképezés), cross-cutting symptom measures. Field trial-ok tesztelik a megbízhatóságot (pl. intraclass kappa indexek [4]). Klinikai vizsgálatok és epidemiológiai felmérések, pszichometriai vizsgálatok.
Empirikus bizonyíték	Korlátozott mennyiségű adat: főként pilot tanulmányok és kvalitatív beszámolók. Egy 13 fős vizsgálatban a változók szoros korrelációját találták (szorongás, stressz, érzelemszabályozás között) [7] ; a testi tünetek gyengébben kapcsolódtak. Ezek előzetes eredmények, melyek alátámasztják az ESV-logikát, de kis mintán születtek. Az ESV-25 inventory statisztikai validálása felvetett, de teljes körű standardizált eredmény még nem publikált [34] [37] .	Széles körű kutatási háttér: megbízhatósági vizsgálatok, epidemiológia, populációs felmérések. A DSM-5 field trial-okban a diagnózisok többsége jó vagy elfogadható megbízhatóságú volt [4] . Sok tudományos cikk vizsgálja különböző zavarok leíró validitását (pl. gén-, neurobiológiai tanulmányok). Kritériumváltozások hatásait populációs adatokon tesztelik (pl. DSM-IV vs DSM-5 prevalencia eltérések). A DSM néha kritizált az érvényesség (validitás) hiánya miatt, de ennek ellenére a legszélesebb körben alkalmazott modell.
Alkalmazás (gyakorlat)	Funkcionális állapotfelmérés és prevenció (például burnout-kockázat, trauma korai jelei) a segítői szakterületeken [5] [21] . Oktatásban és mentálhigiénében kiegészítő eszköz (érzelmi tudatosság, streszkezelés segítése). Elsősorban nem-medikális környezetben, és nem helyettesíti az orvosi ellátást [41] [5] . Terápiás szinten önismereti és kooperatív folyamatokat támogat.	Orvosi és pszichológiai diagnosztika és kezelés alapja: pszichiátriai osztályokon, szakrendeléseken, gondozásban használják. Rendeléskor a betegszámon belüli elbíráláshoz, egészségügyi adminisztrációhoz is ezt alkalmazzák. Kutatásokban kohortbeosztáshoz, gyógyszertesztekben populációk azonosításához veszik igénybe. A pszichiátriai ellátásban követelmény az adott zavar DSM-kritérium szerinti igazolása a diagnózis bejegyzéséhez.

Jellemző / Kritérium	ESV-modell (Odor, 2024–2025) [1] [2]	DSM-5 (APA, 2013) [3] [4]
Erősségek	* Rendszerszemléletű, integrált: dinamikus folyamatokra épít, képes a tünetek mögötti mechanizmusokra rálátni [1] [22] . * Prevenciós fókusz: korai figyelmeztető jelek (burnout, trauma) felismerése, személyre szabott beavatkozás támogatása. * Rugalmas, „közös nyelv” a segítő szakmákban: érzelmi és testi folyamatok összefüggései a közös térképen.	* Széleskörűen használt, egységes szabvány: könnyen kommunikálható diagnózisok és kódok világméretű referenciája [3] . * Magas szakmai konszenzus és hosszú fejlődés: több mint fél évszázados tapasztalat támasztja alá. * Klinikai megbízhatóság: a field trial-ok többsége jó interklinikai egyezést mutatott [4] . * Kutatásokra alapozott: folyamatosan frissülő, empirikus háttér (számtalan tanulmány támasztja alá a kritériumokat).
Gyengeségek / vita	* Kevés tudományos validáció, magyar nyelvű, új modell: nemzetközileg még nem ismert, nincs hivatalos minősítés. * Komplex és sok kategória: elsajátítása és alkalmazása szakértelmet igényel. * Nem klinikai diagnózis: nem orvosi (azaz a legsúlyosabb esetekben nem helyettesíti a pszichiátriai ellátást) [2] . * Főként gyakorlat-specifikus (pedagógia, tanácsadás), hiányoznak a pszichofarmakológiai megerősítések.	* Diagnóziscímke-alapú: kritika érte a patológiák orvosi modellezését és a normalitás túldiagnosztizálását (false positives) [8] . * Vitatott kategóriaváltozások: egyes új diagnózisok (pl. autizmus spektrum) bevezetése, a veszteségi kritériumok megszűntetése vita tárgya volt. * Rugalmatlanabb: kevéssé veszi figyelembe az egyéni narratívát és kultúrát (habár vannak próbálkozások kulturális kiegészítőkkel). * A megbízhatóság sem tökéletes minden zavar esetén (néhány diagnózisban csak közepes korrelációkat találtak [4]).

A fenti táblázatok a két rendszer kulcsfontosságú attribútumait hasonlítják össze, kiemelve az elméleti, diagnosztikus, módszertani és alkalmazási különbségeket.

Ajánlott további kutatási lépések:
- **ESV validáció:** Fókuszált, nagyléptékű empirikus vizsgálatok (kontrollcsoportos, longitudinális) az ESV-25 inventory pontosságának és a kódok klinikai jelentőségének mérésére.
- **Integráció és összehasonlítás:** Az ESV-kódok és DSM/ICD diagnózisok közötti megfelelések kutatása, hatékony kiértékelő rendszer kidolgozása a két modell közötti átjárhatóság biztosítására.
- **Kultúrák közötti adaptáció:** Az ESV-modell nemzetközi adaptálása, hogy felmérjék hatékonyságát eltérő kulturális háttérrel rendelkező populációkon.
- **DSM fejlesztések:** További kutatás a DSM-5 kritikus területein (pl. új zavarok fenntarthatósága, transzdimenziós besorolás hatása, a társadalmi és környezeti kontextus beépítése).
- **Klinikai hatástanulmányok:** Mindkét modell esetén olyan kísérletek, amelyek a gyakorlatban való felhasználás eredményességét vizsgálják (pl. DSM-diagnózis mellett végzett beavatkozás eredménye vs. ESV-vezérelt beavatkozás).

Források: Az elemzés során Antal Ódor eredeti ESV-kézikönyveit és tanulmányait, a DSM-5-TR hivatalos APA-oldalait és szakirodalmi áttekintéseket (pszichiátriai poszttraumás stressz, DSM-vita) használtuk. Az ESV-források közül az integrált szakmai kézikönyv és a pilot vizsgálat voltak a legfőbb támpontok [1]

7 . A DSM-5-re vonatkozó információkat főként az APA weboldaláról és a szakirodalmi áttekintésből merítettük 3 4 8 . Minden adatot a hivatkozott irodalom alapján prezentáltunk.

---

1 2 6 10 11 12 18 19 20 21 22 25 26 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 41 42 (PDF) Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) Modell – Integrált Szakmai Kézikönyv
https://www.researchgate.net/publication/399046039_Az_Erzelem-Stressz-Viselkedes_ESV_Modell_-_Integralt_Szakmai_Kezikonyv

3 16 28 44 Psychiatry.org - DSM
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm

4 DSM-5 field trials in the United States and Canada, Part II: test-retest reliability of selected categorical diagnoses - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23111466/

5 27 (PDF) Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell terepi alkalmazása gyógypedagógiai környezetben: Módszertani b
https://www.academia.edu/144403662/Az_%C3%89rzelem_Stressz_Viselked%C3%A9s_ESV_modell_terepi_alkalmaz%C3%A1sa_gy%C3%B3gypedag%C3%B3giai_k%C3%B6rnyezetben_M%C

7 40 (PDF) Az Érzelem-Stressz-Viselkedés Modell empirikus tesztelése: Egy kérdőíves pilotvizsgálat eredményei
https://www.researchgate.net/publication/396407306_Az_Erzelem-Stressz-Viselkedes_Modell_empirikus_tesztelese_Egy_kerdoives_pilotvizsgalat_eredmenyei

8 23 24 43 annualreviews.org
https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-clinpsy-032814-112800?crawler=true&mimetype=application/pdf

9 35 (PDF) Az ESV-Modell: Az Érzelem-Stressz-Viselkedés kapcsolata a függőségek mechanizmusában
https://www.researchgate.net/publication/396360903_Az_ESV-Modell_Az_Erzelem-Stressz-Viselkedes_kapcsolata_a_fuggosegek_mechanizmusaban

13 14 15 17 Psychiatry.org - DSM History
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/about-dsm/history-of-the-dsm